PSICOLOGIA EM PAUTA

Você sabe mesmo o que um psicólogo faz?

Um dossiê para quem cuida, para quem trabalha em rede e para quem só quer entender melhor onde buscar ajuda.

DIAGNÓSTICO — Se o psiquiatra falou, acabou?

SUAS — Psicólogo virou assistente social?

PSICOFÁRMACOS — Entender medicamento é prescrever?

QUIZ — Quanto do seu conceito ainda é senso comum?





CONTEÚDO AUTORAL DE

Gabriel Batista

Neuropsicólogo | CRP 06/176184

Neuropsicologia aplicada à vida real

QUEM ESCREVE



Gabriel Batista
Neuropsicólogo • CRP 06/176184
Formação e atuação orientadas por Neuropsicologia, análise do comportamento, saúde e trabalho interdisciplinar.

EDITORIAL

A notícia aqui é sobre uma profissão que talvez você ache que conhece.

Quando Psicologia vira apenas “escuta”, perde-se de vista um campo científico que estuda comportamento, cognição, desenvolvimento, aprendizagem, relações, saúde, trabalho e muito mais.

Este editorial nasce de uma pergunta simples: quanto a população realmente sabe sobre Psicologia? Não se trata de disputar espaço com Medicina ou Serviço Social. Trata-se de tornar visível o que cada profissão acrescenta e como elas podem trabalhar juntas sem apagar suas diferenças.

A Psicologia brasileira é uma profissão relativamente jovem, regulamentada em 1962. Desde então, ampliou-se da clínica para escolas, hospitais, organizações, justiça, assistência social, atenção básica, neuropsicologia, reabilitação e pesquisa. A imagem pública, porém, ainda costuma caber num divã.

POR QUE AGORA?

A saúde mental ganhou espaço público, mas a compreensão sobre quem faz o quê não cresceu na mesma velocidade. O resultado é um paciente que circula entre profissionais e, muitas vezes, precisa traduzir sozinho o próprio cuidado.

> **“Se a sua definição de Psicologia cabe apenas na palavra escuta, talvez este dossiê mostre o tamanho do pedaço que ficou de fora.”**

Base: Lei nº 4.119/1962; Resolução CNS nº 218/1997; Resolução CNE/CES nº 1/2023.

CIÊNCIA

Psicologia não é filosofia com consultório.

Ela formula hipóteses, produz medidas, compara grupos, acompanha trajetórias, testa relações, constrói instrumentos e revisa modelos conforme os dados.

“Se a Psicologia não prevê tudo, então não é ciência?”

Não. Ciência não exige adivinhação perfeita. Epidemiologia, medicina, economia e meteorologia também trabalham com incerteza. Em Psicologia, muitas previsões são probabilísticas: diante de determinadas condições, certos comportamentos tornam-se mais ou menos prováveis.

NA CAIXA DE FERRAMENTAS DA CIÊNCIA

- experimentos e estudos observacionais
- psicometria e testes padronizados
- estatística e modelos probabilísticos
- medidas psicofisiológicas e neurociência
- métodos qualitativos e análise contextual



FATO

As diretrizes curriculares atuais exigem formação fundamentada em conhecimento científico e compreensão da complexidade do fenômeno psicológico.

Base: Resolução CNE/CES nº 1/2023; Resolução CNS nº 218/1997.

Gabriel Batista
Neuropsicólogo | CRP 06/176184

PROVOCAÇÃO

“Antes de chamar de depressão, você olhou para o resto da pessoa?”

Sintomas psicológicos não chegam etiquetados com a origem. Corpo, história, medicamentos, sono, ambiente, trabalho e relações podem participar do mesmo quadro.

O modelo biopsicossocial não é um condomínio em que o médico recebe o “bio”, o psicólogo o “psico” e o assistente social o “social”. Cada profissional precisa enxergar a pessoa inteira, ainda que responda por métodos e responsabilidades diferentes.

CASO ILUSTRATIVO

“Estou cansado, sem concentração, sem desejo sexual e não consigo trabalhar. É depressão?”

Pode haver sofrimento depressivo. Também pode haver efeitos de medicamento, alterações do sono, condições clínicas, sobrecarga laboral, uso de substâncias ou outras variáveis. O ponto não é pedir uma bateria de exames para todo mundo. É reconhecer sinais que tornam uma avaliação médica clinicamente indicada.

PSICOLOGIA	funcionamento psicológico, comportamento, história e contexto
MEDICINA	condições clínicas, exame médico, investigação orgânica e tratamento
SERVIÇO SOCIAL	direitos, território, proteção social e condições concretas de vida

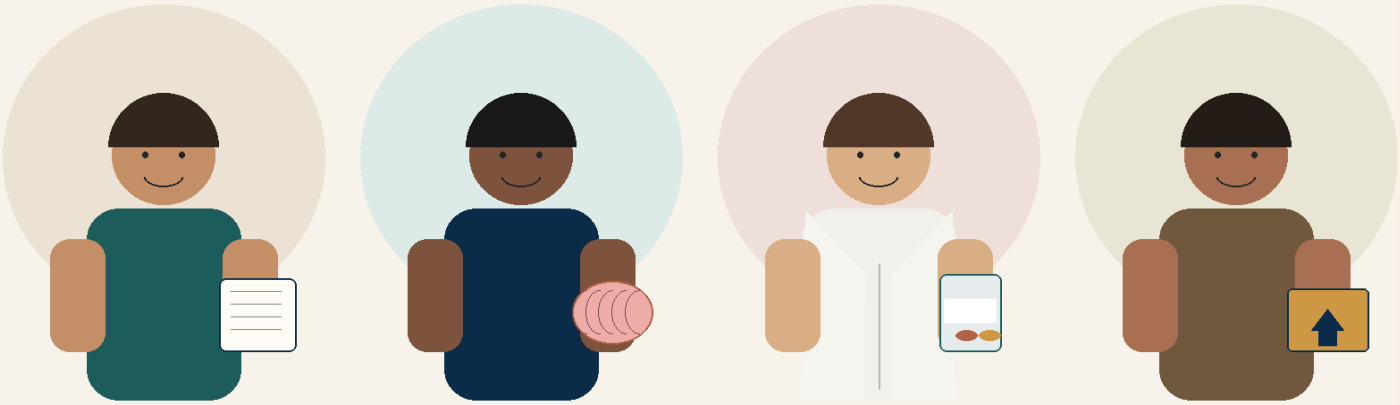


Base: Ministério da Saúde: interprofissionalidade na APS; princípios de integralidade do SUS.

Gabriel Batista
Neuropsicólogo | CRP 06/176184

UMA PESSOA. QUATRO LENTES.

As profissões se encontram, mas não são intercambiáveis. O objetivo



PSICÓLOGO	NEUROPSICÓLOGO	PSIQUIATRA	ASSISTENTE SOCIAL
processos psicológicos	cognição e funcionalidade	medicina e farmacoterapia	direitos e políticas sociais

PSICÓLOGO

Avalia e intervém sobre processos psicológicos e comportamento. Pode atuar em clínica, saúde, educação, trabalho, justiça, políticas públicas, pesquisa e outros campos.

NEUROPSICÓLOGO

É psicólogo com especialização reconhecida. Investiga relações entre cognição, comportamento e funcionalidade, com avaliação e intervenção neuropsicológica.

PSIQUIATRA

É médico. Realiza avaliação médica em saúde mental, diagnóstico diferencial médico e manejo farmacológico quando indicado.

ASSISTENTE SOCIAL

Atua sobre direitos, políticas sociais, condições concretas de vida, proteção social, acesso a serviços e estudos sociais/socioeconômicos.

“Interdisciplinaridade não é todo mundo fazer a mesma coisa. É saber onde seu trabalho encontra o do outro.”

Base: Lei nº 4.119/1962; Lei nº 8.662/1993; CFP - Manual de Neuropsicologia; CFM/legislação médica.

DIAGNÓSTICO

“Se o psiquiatra falou, acabou?”

Não. Uma hipótese diagnóstica pode ser revisada. O valor do diagnóstico está na qualidade das evidências, no raciocínio diferencial e na evolução do caso, não apenas no título de quem o formulou.

O psicólogo realiza diagnóstico psicológico dentro de suas competências e pode integrar classificações diagnósticas quando isso for tecnicamente pertinente. O psiquiatra realiza diagnóstico no âmbito médico, podendo investigar condições orgânicas e prescrever. Nenhum dos dois transforma uma primeira conversa em verdade imutável.

NEUROPSICOLOGIA

Um teste não fecha um diagnóstico.

Avaliação neuropsicológica integra entrevista, história, observação, dados funcionais, instrumentos padronizados e análise do contexto. Atenção, memória, linguagem ou funções executivas são partes de um perfil, não etiquetas isoladas.



POR QUE O DIFERENCIAL IMPORTA?

Oscilações de humor, impulsividade, necessidade de atenção, conflitos interpessoais ou grandiosidade podem aparecer em quadros diferentes. Em casos complexos, história longitudinal e integração de fontes valem mais do que um sintoma solto.

Base: Lei nº 4.119/1962; Resolução CFP nº 06/2019; CFP - Manual de Neuropsicologia: ciência e profissão.

Gabriel Batista
Neuropsicólogo | CRP 06/176184

PERGUNTA INCÔMODA

“Se o psicólogo não prescreve, por que deveria entender psicofármaco?”

Porque medicamentos podem alterar sono, libido, atenção, memória, apetite, ansiedade, energia e comportamento. Ignorar isso também fragmenta o cuidado.



1 COMPREENDER

efeitos percebidos, adesão, impacto psicológico e sinais de alerta

2 COLABORAR

registrar, encaminhar e conversar com o prescritor quando houver consentimento e necessidade

3 PRESCREVER

selecionar fármaco, dose, titulação e monitoramento: competência legal específica

E NOS ESTADOS UNIDOS?

Algumas jurisdições permitem prescrição por psicólogos especialmente treinados, com formação biomédica adicional, prática supervisionada e regras próprias. Não é autorização geral para qualquer psicólogo.

“Entender não é prescrever. Mas não entender também pode empobrecer o cuidado.

Base: APA Guidelines for Psychologists’ Involvement in Pharmacological Issues; APA 2026 prescribing updates.

Gabriel Batista
Neuropsicólogo | CRP 06/176184

SUAS

“Quando a política é social, o psicólogo vira assistente social?”

Não. Estar no mesmo equipamento não apaga formação, método e atribuições. Há atividades compartilháveis e núcleos profissionais diferentes.

COMPARTILHAM

acolhimento • trabalho em equipe • articulação de rede • planejamento • discussão de casos • defesa do acesso a direitos e cuidado

PSICOLOGIA ACRESCENTA

processos psicológicos, vínculos, comportamento, desenvolvimento, sofrimento, grupos e funcionamento psicológico.

SERVIÇO SOCIAL ACRESCENTA

direitos, políticas sociais, benefícios, proteção social, condições concretas de vida, estudos sociais e socioeconômicos.



O PACIENTE NÃO É PENDRIVE

Rede de cuidado precisa de comunicação responsável, consentimento e contrarreferência quando pertinente. A pessoa não deveria ser obrigada a traduzir sozinha cada pedaço do caso.

“Quando uma profissão é usada para tapar o buraco da outra, isso não é interdisciplinaridade. É precarização.”

Base: CFP - Referências Técnicas para atuação no CRAS/SUAS; Lei nº 8.662/1993; Ministério da Saúde - Ações Interprofissionais.

Gabriel Batista
Neuropsicólogo | CRP 06/176184

BASTIDORES

“O paciente vê a sessão. Nem sempre vê o trabalho que sustenta a sessão.”

Correção de instrumentos, integração de dados, registro, elaboração de documentos, consulta à literatura, planejamento e comunicação em rede também consomem tempo técnico.



50 min — ATENDIMENTO

\+ REGISTRO E ORGANIZAÇÃO

\+ CORREÇÃO / ANÁLISE

\+ INTEGRAÇÃO E HIPÓTESE

\+ DOCUMENTAÇÃO / DEVOLUTIVA

30 HORAS: POR QUE ESSA DISCUSSÃO IMPORTA?

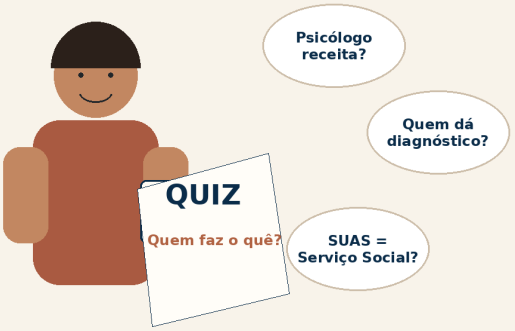
A jornada não é apenas um debate corporativo. Ela conversa com qualidade do trabalho, produção documental, desgaste emocional e tempo técnico invisível. Em 2026, a proposta legislativa segue em tramitação e não deve ser apresentada como direito já vigente.

Base: Resolução CFP nº 06/2019; Câmara dos Deputados - PL 1.214/2019 (tramitação consultada em 2026).

QUIZ

Quanto do seu conceito de Psicologia ainda vem do senso comum?

Marque a alternativa que melhor representa sua resposta. O objetivo não é "dar nota" em ninguém. É descobrir quais fronteiras profissionais você ainda pode querer pesquisar.



1. Se um paciente relata queda de libido após iniciar antidepressivo, o psicólogo deve:

- ☐ A) ignorar porque é assunto médico
- ☐ B) investigar impacto e encaminhar ao prescritor quando necessário
- ☐ C) orientar redução da dose

2. Uma avaliação psicológica usa testes. Então o diagnóstico vem do teste?

- ☐ A) Sim
- ☐ B) Não. O instrumento é uma fonte integrada a outras informações

3. No SUAS, psicólogo e assistente social podem executar qualquer função um do outro?

- ☐ A) Sim, porque ambos são equipe técnica
- ☐ B) Não. Há ações comuns e competências próprias

4. Encaminhar à UBS significa que o psicólogo "não deu conta"?

- ☐ A) Si

Pontuação: marque 2 pontos para a resposta que reconhece integração + limites; 1 ponto quando a resposta depende do contexto; 0 para simplificações que apagam competências.



Gabriel Batista
Neuropsicólogo | CRP 06/176184

5. Quem pode ser a primeira porta de entrada para sofrimento mental?

- ☐ A) Só o psiquiatra
- ☐ B) Só o psicólogo
- ☐ C) Depende do caso: Psicologia, Medicina/APS ou outros pontos da rede podem iniciar o cuidado

6. Um neuropsicólogo encontra prejuízo importante de memória. Isso sozinho fecha um

- ☐ A) Sim
- ☐ B) Não. É preciso integrar história, funcionalidade, outros dados e, quando indicado, avaliação médica

7. Psicólogo precisa saber alguma coisa sobre psicofármacos?

- ☐ A) Não, porque não prescreve
- ☐ B) Sim, para compreender efeitos psicológicos/comportamentais e trabalhar em rede sem ultrapassar seu escopo

8. “Biopsicossocial” significa dividir a pessoa entre três profissões?

- ☐ A) Sim
- ☐ B) Não. Cada profissão precisa considerar o todo a partir de sua competência

SE VOCÊ É PACIENTE, ESTAS PERGUNTAS TAMBÉM SÃO SUAS

- Qual é a hipótese neste momento?
- Que outras possibilidades foram consideradas?
- Há algo clínico que vale investigar?
- Os profissionais que me atendem precisam conversar entre si?

Participar do próprio cuidado não é se autodiagnosticar. É poder perguntar.

SEU SCORE NÃO É UMA NOTA

Ele mede apenas familiaridade com uma lógica interdisciplinar. Use como convite para pesquisar, não como selo de competência.

0–5 Alguns clichês ainda estão trabalhando por você.

6–10 Você reconhece diferenças, mas algumas fronteiras ainda parecem rígidas.

11–13 Seu olhar já percebe complementaridade e limites.

14–16 Você está pensando em rede. Agora vem o desafio de sustentar isso na prática.



Gabriel Batista
Neuropsicólogo | CRP 06/176184

FUTURO

A Psicologia precisa crescer sem ficar irreconhecível.

Mais espaço profissional exige mais clareza pública sobre ciência, avaliação, diagnóstico, trabalho em rede, limites éticos e responsabilidade social.



CIÊNCIA PÚBLICA	comunicar evidências sem virar jargão nem conteúdo raso
IDENTIDADE PROFISSIONAL	mostrar que Psicologia não se resume à psicoterapia
AVALIAÇÃO	valorizar instrumentos e raciocínio clínico sem transformar teste em fetiche
REDE	melhorar comunicação entre Psicologia, Medicina, Serviço Social e demais áreas
TRABALHO	tornar visível o tempo técnico, condições de exercício e debate das 30 horas

> **“O corpo não termina onde começa a mente. A mente não termina onde começa a sociedade. E nenhuma profissão precisa diminuir a outra para enxergar melhor um ser humano.”**

REFERÊNCIAS ESSENCIAIS • FORMATO EDITORIAL ABNT

BRASIL. Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo.

BRASIL. Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução nº 218, de 6 de março de 1997. Reconhece categorias profissionais de saúde de nível superior.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de outubro de 2023. Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CFP nº 06/2019. Regras para elaboração de documentos escritos produzidos pela(o) psicóloga(o).

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Manual de Neuropsicologia: ciência e profissão. Brasília: CFP.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) no CRAS/SUAS. Brasília: CFP/CREPOP.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ações interprofissionais na Atenção Primária à Saúde. Brasília: MS.

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Guidelines for Psychologists’ Involvement in Pharmacological Issues. Washington, DC: APA.

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Updates on prescribing authority for specially trained psychologists in U.S. jurisdictions. 2026.

CFESS. Parâmetros e legislação profissional do Serviço Social. Brasília: Conselho Federal de Serviço Social.

BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 1.214/2019. Jornada de trabalho de psicólogas(os). Tramitação consultada em 2026.

Imagens de apoio: recortes do editorial autoral “Relações em Pauta” enviado pelo autor, usados como referência visual nesta prova de diagramação.

Documento educativo. Não substitui avaliação profissional individual. Referências completas e normalização ABNT devem ser revisadas na edição final de publicação.



Gabriel Batista
Neuropsicólogo | CRP 06/176184